

CANCER DE L'ENDOMETRE



Rappels:

QE!!

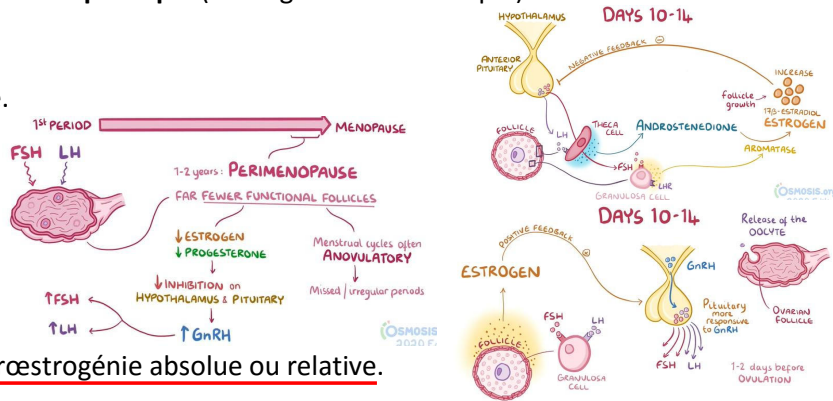
I. INTRODUCTION :

- Cancer de la **femme ménopausée**.
- Diagnostic **souvent** fait à un **stade précoce**, signe classique : **métrorragies post-ménopausiques** -> confirmé par **biopsie + examen histologique**.
- Les facteurs pronostiques guident la **stratégie thérapeutique** (chirurgie et radiothérapie).
- Pronostic** dominé par **2 facteurs** :
 - Grading de différenciation.
 - Degré de pénétration dans le myomètre.



II. EPIDEMIOLOGIE :

- 13,6 nouveaux-cas pour 100 000 F/an.
- Pic de prévalence : 59 ans.
- Maladie des pays riches.
- Race blanche +++.
- Cancer hormono-dépendant : terrain d'hyperœstrogénie absolue ou relative.



Rappel physiologique :

- Chaque follicule comprend une **couche externe dénommée thèque**, une **couche interne appelée granulosa** et un ovocyte central.
- La GnRH stimule la sécrétion de FSH et LH : ↗ du taux de GnRH hypothalamique à partir du 1^{er} jour du cycle.
- La FSH et LH stimulent la croissance et la maturation du follicule ainsi que la sécrétion des œstrogènes :
 - La **LH stimule les cellules thécales** qui sécrètent alors les **androgènes**.
 - Ces hormones diffusent à travers la membrane basale, où elles sont **transformées en œstrogènes (E2) par les cellules de la granulosa stimulées par FSH**.
- La synthèse des œstrogènes est **bicellulaire**.
- Chez la femme ménopausée, la sécrétion de FSH/LH est toujours présente sans follicules avec persistance de quelques cellules thécales -> donc chez la femme ménopausée 2 origines d'androgènes : androgènes ovariens et androgène surrénaliens +++.**

III. FACTEURS DE RISQUE

1. Facteurs généraux :

- HTA, Diabète +++.**
- Hérédité** (contexte familial) : cancer du sein, côlon (**syndrome de Lynch = HNPCC**), ovaire : Kc à âge précoce (< 50 ans).

2. Facteurs hormonaux : exposition aux œstrogènes en l'absence absolue ou relative de progestatif :

- Obésité** : augmentation du taux d'œstrone plasmatique (E1) par aromatisation des androgènes dans le tissu adipeux (E1 plus actif que E2 et difficilement catabolisé par le foie).
- Nulliparité** : la multiparité protège contre le cancer (grossesse + post-partum : diminuent l'action des œstrog -> protègent la femme).
- Puberté précoce et/ou ménopause tardive** (large fenêtre œstrogénique).
- Hyperœstrogénie endogène** : **SOPK**, tumeurs sécrétantes de l'ovaire (tumeur de la granulosa (androgènes +++)) / tumeur thécale (œstrogènes +++)).
- Hyperœstrogénie exogène** : **THS non contrebalancé par les progestatifs, CO séquentielle** (CO combinée : dès le 1^{er} jour du cycle : œstro + progestérone / CO séquentielle : 1^{er} jour au 14^{ème} jour -> œstro puis du 15^{ème} jusqu'à la fin du cycle -> œstro + progestérone).
- Tamoxifène +++** (ttt anti-hormonal du kc du sein : bloque les récepteurs œstrogéniques au niveau sein mais effet paradoxal au niveau des récepteurs de l'endomètre (agit comme œstrogène-like) -> risque de Kc endomètre) : surveillance +++.

3. Facteurs utérins :

- Lésions précancéreuses** : hyperplasie endométriale atypique (considérée comme une dysplasie sévère -> TTT chirurgical sinon risque d'évolution vers kc).
- ATCD d'irradiation pelvienne.**

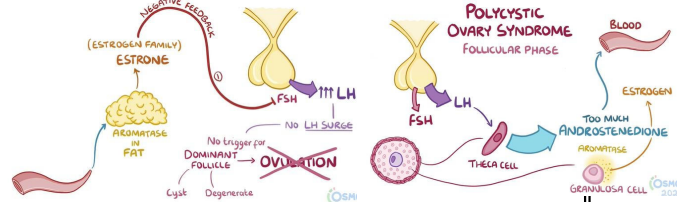
FACTEURS DE RISQUE

À réviser

QE!!

Facteurs hormonaux	Facteurs héréditaires : 2-5 %	Généraux		Hormones (hyperœstrogénie) > 90%		Génétiques*
			Endogènes	Exogènes		
Hyperœstrogénie	Le syndrome de Lynch	Age: 90 % après 50ans diab 15% en postménopausée et 75 % prémenopausées. Race blanche 2x/ noire	Obésité (IMC > 25) Diabète II, Sd métabolique Syndrome des ovaires polykystiques Ménarche précoce, ménopause tardive Nulliparité Tumeur ovarienne sécrétante	Traitement hormonal substitutif Tamoxifène (traitement hormonal du cancer du sein)		Syndrome de Lynch < 5%: transmission AD, altération constitutionnelle d'un gène du système MMR Syndrome de Cowden/tumoral et hémorragies, mutation germinale PTEN
Obésité, HTA, Perturbations hormonales (OPK, tumeurs ovariens)	Syndrome de Cowden (x 3 à 5)					
Traitement substitutif Tamoxifène (x 2 à 4).						

QE!!

**SOPK :**

- Normalement $FSH/LH > 1$ -> dans le SOPK : $LH > FSH$.
- Conséquence : **hyperandrogénie + cycles lents** (> 32 jours : lors d'un cycle normal, pic œstrogénique précédant le pic LH # SOPK : pas assez d'œstrogènes -> pas de pic LH -> pas d'ovulation -> cycle lent).
- **Signes cliniques : spanioménorrhée, hirsutisme (poils +++), chute de cheveux temporale, grande taille avec souvent obésité +++** (-> œstrogènes +++ : hypertrophie endomètre -> **Kc endomètre à âge plus jeune 45 – 50 ans**).
- Signes biologiques : $LH +++$, androgènes +++ / signes écho : ovaires polykystiques (car pas d'ovulation -> accumulation des follicules).
- 3 risques : risque à court terme (hypofertilité), à moyen terme (DT2 (RI)), à long terme (Kc endomètre).

IV. ANATOMOPATHOLOGIE :

- **Adénocarcinome de l'endomètre : 80% +++** (bon pronostic, évolution favorable 80 à 90%).

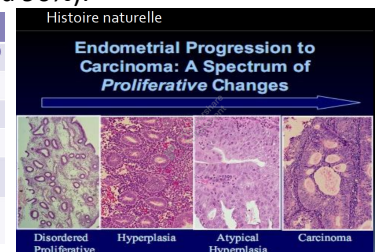
- **3 grades :**

- **Grade I :** bien différencié.
- **Grade II :** moyennement différencié.
- **Grade III :** indifférencié.

- Plus rarement :

- Adénoacanthome : 10% (endomètre normal).
- Carcinome adénoquameux : 2,5 %.
- Carcinome squameux (2,5 %) : carcinome épidermoïde (ressemble aux ç cervicales)
- Cancer à cellules claires : 2,5 % (ressemble aux cellules ovariennes)
- Cancer papillaire séreux : 2,5% (ressemble aux cellules ovariennes ou TD)
- Sarcome (point départ conjonctif).

	Cancer type I	Cancer type II
Age	Péri-ménopause : 55 ans	>65 ans (post ménopause)
Fréquence	Fréquent : 80 %	20%
Hormonodépendance	Hormonodépendant, hyperœstrogénie	Non hormonodépendant
Type histologique	Adénocarcinome endométricid	Adénocarcinome séreux, cellules claires
Lésions précancéreuses	Hyperplasie complexe atypique	Carcinome endométrial intraépithélial séreux
Anomalies moléculaires	Instabilité microsatellites (Sd Lynch, 30% sporadiques) Mutation PTEN, KRAS, CTNNB1.	Mutation P53:90% Mutation HER 2 Protéine P16 :100%



Très mauvais pronostic

**V. DIAGNOSTIC :**

1. Circonstances de découverte :

- **Métrorragies +++** : spontanées, irrégulières (intermittentes +++) chez une femme en péri- ou post-ménopause.
- ➔ **Pas de parallélisme entre quantité de saignement et le risque de cancer : tout saignement (que soit son abondance) chez une femme ménopausée est un kc de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire.**
- Infection post-ménopausique.
- **Leucorrhées** : purulentes (pyorrhée), séreuses (hydrorrhée)

- Les leucorrhées physiologiques chez la jeune femme sont secondaires à l'action d'œstrogènes -> hypertrophie vaginale -> desquamation des cellules riches en glycogènes -> colonisation par les bacilles de Doderlein -> humidification du vagin -> leucorrhées physiologiques.
- Chez la femme ménopausée, pas d'œstrogènes -> atrophie vaginale -> jamais de leucorrhées.

Toute leucorrhée séreuse chez femme ménopausée témoigne d'une imprégnation hormonale +++ => probablement kc d'endomètre sous-jacent +++.

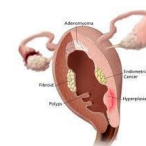
- Douleur pelvienne : signe tardif, révélateur d'une forme évoluée.

Toute métrorragie ou leucorrhée post-ménopausique = cancer de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire

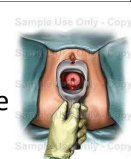
➔ Doivent faire indiquer la pratique d'une exploration endo-utérine.

2. Examen clinique :

- **Interrogatoire** : FDR, terrain.
- **Examen général** : TA, Poids, état cardio-vasculaire et métabolique.
- **Examen gynécologique** :
 - **Trophicité vulvo-vaginale** (signes d'imprégnation hormonale +++ : trophicité, muqueuse rose).
 - **Spéculum** : vagin, col, origine du saignement +++ (parfois saignement en rapport avec l'atrophie vaginale post-ménopausique : spéculum -> fissurations -> réduit la probabilité de Kc de l'endomètre car témoin de l'absence d'œstrogènes).
 - **TV** : utérus souvent normal (femme ménopausée : l'utérus doit être de petite taille), gros, mou.
 - **TR** : paramètres (important pour la stadification du Kc).
- **Examen des seins, aires ganglionnaires, foie** (métas à distance).
- **FCV** : sa positivité = lésion étendue au col (sa négativité n'élimine pas le Kc de l'endomètre).



Cause of bleeding	Frequency (%)
Endometrial or cervical polyps	2-12
Endometrial hyperplasia	5-10
Endometrial carcinoma	10
Exogenous oestrogens	15-25
Atrophic endometritis and vaginitis	60-80
Other (vaginal trauma, urethral caruncle, uterine sarcoma, cervical cancer, anticoagulants)	



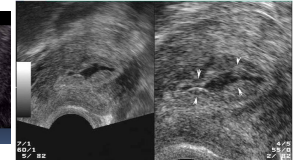
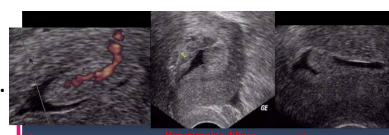
3. Examens complémentaires :

a) **Echographie : abdominale, endovaginale +++**

- **Épaisseur endomètre** : épaississement de la ligne d'interface si > 4 mm ou > 8 mm si THS = hypertrophie de l'endomètre (=> pouvant être : cancer, hyperplasie simple, hyperplasie atypique, fibrome ou polype).
- **Siège des lésions endocavitaires** (-> si extension vers l'isthme : ttt comme Kc col -> **colpohystérectomie élargie**), **infiltration du myomètre**.
- **Doppler** : vascularisation anormale (anarchique -> Kc endomètre).
- **ADP iliaque, ascite**.

b) **Hystérosonographie** : injection de sérum physiologique dans la cavité utérine, plus sensible et plus spécifique : permet de trancher entre cancer, hyperplasie simple ou atypique, polype ou fibrome sous-muq :

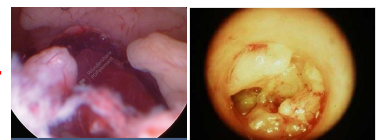
- Polype : masse bien limitée pédiculée.
- Fibrome : masse bien limitée et accolée à la paroi.
- Hyperplasie : épaississement de part et d'autre du liquide.
- Cancer de l'endomètre : masse mal limitée.



c) **Hystéroscopie** : (en ambulatoire ou sous sédation) :

- **Si hystérosonographie non réalisée**.
 - **Aspect, topographie de la tumeur** : bourgeonnante, friable, saigne au contact.
 - **Extension vers l'isthme, col**.
 - Guide la **biopsie**.

=> **Une hystéroscopie normale élimine le cancer de l'endomètre.**



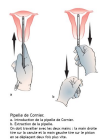
d) **Curetage biopsique étagé** :

- **Si hystérosonographie et hystéroscopie non réalisées ????????**
 - Hystéroscopie endocervical puis endo-utérin.
 - Curetage diagnostique réalisé à la curette au décours de l'hystéroscopie, des trois étages distincts de l'utérus et de façon séparée : premièrement le curetage du canal endocervical, puis le curetage de la région cervico-isthmique et enfin le curetage de la cavité du corps utérin.
- Diagnostic histologique précis (type histologique + grade) + préciser la limite par rapport à l'isthme utérin.



e) **Autres moyens diagnostics** :

- Cytologie par frottis endométrial (**cytobrush**)
- Biopsie de l'endomètre à la **canule de Novak** ou à la **pipelle de Cornier** (peut être réalisée en ambulatoire).
 - ➔ Gestes faciles, mais faux négatifs car à l'**aveugle** : **VPP +++ mais VPN médiocre** (si - : pas prise en considération : sa négativité n'élimine pas le cancer).



La biopsie de l'endomètre est indispensable car elle permet l'analyse histologique et le diagnostic de certitude de cancer de l'endomètre : préciser le type histologique et le grade -> passer au bilan d'extension.

f) **Hystérographie : HSG** :

- CI +++ : risque important de FP et FN.
- N'a plus de place dans le kc de l'endomètre : abandonnée en raison du développement de l'échographie endovaginale et de l'hystéroscopie.

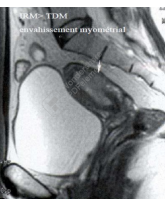


Résumé : 2 possibilités :

- > Echo endovaginale (+/- hystérosonographie) puis biopsie de l'endomètre à l'aveugle -> Dc posé -> bilan d'extension.
- > Echo endovaginale compléter par hystéroscopie (systématique pour certains, d'autres ne le réaliseront que si le Dc de cancer n'a pas été réalisé par biopsie d'endomètre) avec curetage biopsique étagé -> DC posé -> bilan d'extension.

VI. BILAN D'EXTENSION :

- Examen clinique parfois sous AG : paramètres.
- **IRM +++ : 1^{er} examen à faire pour le bilan d'extension** (sensibilité et spécificité proche de l'anaph !) :
 - > **IRM pelvienne et des aires ganglionnaires lombo-aortiques** :
 - Invasion myométriale.
 - Atteinte col, isthme.
 - Atteinte vessie, rectum, paramètres.
 - ADP lombo-aortiques, iliaques.
- **TDM abdomino-pelvienne** : ne fait pas partie du bilan d'extension sauf en cas de contre-indication à l'IRM. Dans ce cas, il doit être associé à l'échographie pelvienne.
- **Cystoscopie, UIV, rectoscopie, coloscopie** : si signes d'appel.
- **TDM TAP** : recherche de métastases à distance (foie, poumon, os,...) si signes d'appel, pas systématique.
- **Bilan d'opérabilité** : patientes ayant souvent un mauvais état général (obésité, diabète, HTA).



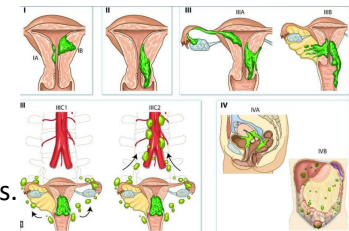
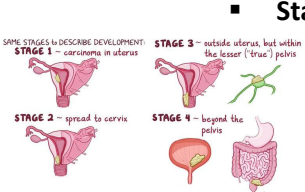
VII. CLASSIFICATION :

- FIGO basée sur les constatations opératoires : la classification FIGO du kc de l'endomètre sera réalisée après le geste chirurgical +++.
- Les stades TNM se basent sur la classification clinique ou pathologique, ou bien sur les deux. Les stades de la FIGO se basent sur la stadification chirurgicale.

Nouvelle classification FIGO 2009 :

- Stade I : tumeur limité au corps utérin :**
 - IA G1,2,3** : infiltration $\leq 50\%$ épaisseur myomètre.
 - IB G1,2,3** : infiltration $> 50\%$ épaisseur myomètre.
- Stade II : G,1,2,3** : invasion du stroma cervical (envahit le col) sans extension au-delà de l'utérus.
- Stade III :**
 - IIIA G,1,2,3** : atteinte séreuse et/ou l'un des annexes.
 - IIIB** : métastase(s) vaginale(s) et/ou atteinte paramétriale.
 - IIIC G,1,2,3** : métastase(s) ganglionnaire(s) pelvienne(s) ou paraaortique(s) :
 - IIIC1** : ganglions pelviens positifs sans gg para-aortique.
 - IIIC2** : ganglions para-aortiques positifs avec ou sans gg pelviens.
- Stade IV :**
 - IVA G,1,2,3** : atteinte muqueuse de la vessie et/ou du rectum sans métastase à distance.
 - IVB** : métastase(s) abdominale(s) et/ou distance et/ou N+ inguinal +++

Risque bas	Risque intermédiaire	Risque élevé
- Stades IA - Grade 1 ou II - Type 1	- Stade IA, grade 3, type 1 - Stade IB, grade 1 ou 2, type 1	- Stade IB, grade 3, type 1 - Stade IA-B, type 2 - Stade I présentant des embolies lymphatiques



Devant tout cancer de l'endomètre, toujours examiner l'aire ganglionnaire inguinale +++ → si ADP : stade IVB de FIGO → pas de place à la chirurgie → radio-chimiothérapie.
Parce que le drainage de l'endomètre ne se fait pas par les ganglions inguinaux (les ganglions inguinaux, par contre, assurent le drainage de la vulve → devant kc de la vulve avec ADP inguinales : chirurgie toujours possible).

VIII. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL :

→ Devant des métrorragies en péri- ou post-ménopause :

1. Causes vulvo-vaginales :

- Vaginite sénile** (vagin atrophique par hypoœstrogénie post-ménopause -> fissurations -> saignement).
- Cancer de la vulve ou cancer du vagin (essentiellement de la face post).
- Lésion traumatique vulvo- vaginale** (post-coïtal +++ : vagin non humide -> déchirures -> saignement abondant car bien vascularisé).
- Corps étranger vaginal, permanganate de potassium.**

2. Cause cervicale :

- Cancer du col** (chez la femme ménopausée, il est surtout à l'intérieur de l'orifice -> aspect du col normal au spéculum -> TV : col rigide +++ -> si persistance de doutes : hystéroscopie avec curetage biopsique).
- Polype accouché par le col** (« un polype appelle un autre polype » -> explorer toute la cavité utérine pour rechercher d'autres polypes pouvant se dégénérer en cancer !).
- Ulcération cervicale sur prolapsus génital** (accouchements multiples -> prolapsus génital : col, vessie, ... -> ulcération car ces organes ne sont pas habitués au milieu extérieur).

3. Cause endo-utérine :

- Fibrome sous-muqueux ou interstitiel.**
 - Polype endométrial.**
- Ne les retenir que lorsqu'on est sûr d'avoir éliminé le kc de l'endomètre.

4. Cause annexielle :

- Tumeur de la trompe** (métastases au niveau de l'endomètre -> saignement).
- Tumeur de l'ovaire** (métastases au niveau de l'endomètre ou tumeur hypersécrétante d'œstrogènes).

5. Infection : cervicite, endométrite (rare chez la femme ménopausée -> si endométrite : penser à un kc d'endomètre surinfecté), vaginite.

6. Causes fonctionnelles : hyperplasie (obésité, ...), atrophie endomètre (par fissuration).

7. Iatrogène : ATC, THS (prédisposée à faire cancer de l'endomètre).

IX. EVOLUTION, PRONOSTIC :

1. Evolution

- Evolution spontanée – Histoire naturelle.
- L'évolution générale est en règle lente, avec hémorragies, anémie, surinfection, douleurs pelviennes et signes d'envahissement de voisinage.
- La dissémination extra-utérine est tardive (vers les chaînes Gg (Gg iliaques), vagin, annexes, péritoine).
- Les métastases sont rares (foie, poumon, cerveau).

2. Facteurs pronostiques :

- **Age** : âge élevé de mauvais pronostic -> car souvent patiente non opérable : comorbidités associées.
- **Bilan d'opérabilité** : les tares viscérales peuvent limiter les indications chirurgicales.
- **Stade FIGO** : bon pronostic pour les cancers traités à un stade précoce (stade I, II).

FIGO	I	II	III	IV
Survie à 5 ans %	80	60	30	10

RISQUE BAS	RISQUE INTERMÉDIAIRE	RISQUE ÉLEVÉ
Stades Ia/T1a, grade 1 ou 2 (type 1 histologique)	Stades Ia/T1a, grade 3 (type 1 histologique) Stades Ib/T1b, grade 1 ou 2 (type 1 histologique)	Stades Ib/T1b, grade 3 (type 1 histologique) Stades Ia-B/T1 (type 2 histologique) Stades I/T1 présentant des embolies lymphatiques*

- **Type histologique** : adénocarcinomes et adénoacanthomes sont de meilleur pronostic.
- **Grade histo-pronostique** : gravité des formes peu ou non différenciée de grade III.
- **Envahissement myométrial** : risque de récurrence pelvienne.
- **Envahissement ganglionnaire** : mauvais pronostic.
- **Cytologie péritonéale** : si cytologie positive -> risque de récurrence extra-pelvienne +++.

Quelles chances de survie ?

- Taux de survie global à 5 ans
 - Stade I = 90%
 - Stade II = 75%
 - Stade III = 31%
 - Stade IV = 9,1%

X. TRAITEMENT :

1. Préventif :

- Ne pas prescrire de traitements œstrogéniques au long cours sans équilibration parallèle en progestatifs.
- Traitement des polypes (polype asymptomatique chez femme jeune -> ne pas traiter # traiter si femme ménopausée) et les hyperplasies de l'endomètre (traitement médical par progestatifs : per os – stérilet à base de progestatifs pendant 5 ans ou bien traitement chirurgical : endométréctomie).
- Surveillance des malades sous tamoxifène : écho chaque 1 – 3 mois à la recherche d'une hyperplasie.

2. Curatif :

a) Chirurgie :

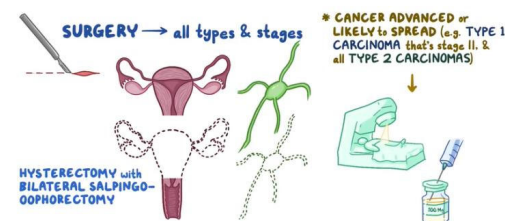
- Opérabilité (patientes avec comorbidités).
- Exploration peropératoire, cytologie péritonéale (-> si signes d'envahissement importants avec patiente âgée -> pas la peine de faire un traitement radical).
- HTEF + annexectomie bilatérale par voie abdominale + prélèvement ganglionnaire sous-veineux iliaque = intervention de base.
- Colpo-hystérectomie élargie aux paramètres (type II de Piver) + lymphadénectomie pelvienne.
- Hystérectomie vaginale + annexectomie bilatérale.
- Hystérectomie par cœliochirurgie + lymphadénectomie pelvienne.
- Autres gestes possibles : omentectomie (cancer à cellules claires : ttt comme kc ovaire), exentération pelvienne antérieure ou postérieure (si vessie ou rectum atteints).

b) Radiothérapie :

- **Externe** : 45-50 Gys : 1,8-2 Gy en 5 séances / semaine (ADP pelviennes +++).
- **Curiathérapie** :
 - Vaginale postopératoire (risque de récurrences sur vagin +++).
 - Utéro-vaginale préopératoire.
 - Interstitielle.
 - Endo-utérine.

c) Traitement médical :

- **Hormonothérapie** :
 - Anti-aromatases (diminuer le risque de méas chez femme non opérable).
 - Progestatifs : Medroxyprogestérone (même principe).
- **Chimiothérapie** :
 - Association des antimétabolites actifs : Carboplatine + taxol.
 - Autres : Cisplatine et Adriamycine ou épirubicine, anthracyclines liposomées.



3. Indications :

a) Stade I :• **Malade opérable :**

- Hystérectomie sans conservation + prélèvements ganglionnaires sous veineux.
- Envahissement Myomètre < 50%
- Grade I ou II
- Ganglions Négatifs
- Envahissement Myomètre > 50%
- Grade III
- Ganglions envahis

Curiethérapie vaginale

Radiothérapie pelvienne + Curiethérapie

• **Malade inopérable :**

- RTE + curiethérapie utérovaginale.

b) Stade II :

- Colpohystérectomie + lymphadénéctomie sans conservation.
- Si N+ → Radiothérapie.
- Si N - → Curiethérapie.

c) Stade III :

- Chirurgie si possible, sinon radiothérapie.

d) Stade IV :

- Chirurgie si possible, sinon radiothérapie et hormonothérapie.

Stade I (de type 1 histologique) :

- Risque bas (de récurrence) : stade IA de grade 1 ou 2
- Hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale.
- Curiethérapie postopératoire peut être discutée en cas d'envahissement myométriale
- Risque intermédiaire : stade IA de grade 3, IB de grades 1 ou 2
- Hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale.
- Lymphadénéctomie pelvienne peut être envisagée si
- IA grade 3 avec envahissement myométrial.
- IB grade 3
- Curiethérapie post opératoire.

Stade I (de type 2 histologique) :

- Risque élevé : stade IB de grade 3 ou stade I avec embolies lymphatiques
- Hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale
- Lymphadénéctomie Lombo-aortique et iliaque commune (+/- Lymph pelv peut être discutée)
- Radiothérapie externe pelvienne postopératoire
- +/- curiethérapie de surimpression (post opératoire) (peut être discutée)

Stade II (de type 2 histologique) :

- Hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale.
- Lymphadénéctomie pelvienne et lombo-aortique.
- Cytologie péritonéale et biopsies péritonéales.
- Omentectomie infra colique (si carcinome a cellules claires ou papillaire séreux)
- Radiothérapie post opératoire (45 Gy).
- +/- Curiethérapie de surimpression (peut être discutée)
- +/- Chimiothérapie adjuvants (peut être discutée)

Stade II (tout type histologique) :

- Hystérectomie totale +/- élargie avec annexectomie bilatérale.
- Lymph pelvienne +/- lombo-aortique (si Type 2 ou Type 1 : d'emblée ou si curage pelvien +/-)
- +/- Cytologie péritonéale, biopsies péritonéales, Omentectomie infra colique (type 2 histologique)
- Radiothérapie post opératoire (45 Gy)
- Curiethérapie post opératoire
- +/- chimiothérapie adjuvants séquentielle (type 2 histologique)
- En cas d'atteinte de gros volume du col utérin, une radiothérapie préopératoire externe pelvienne (45 Gy) avec ou sans curiethérapie préopératoire (15 Gy) peuvent être discutées

Stade III (tout type histologique) :

- Stade IIIA :
- Hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale
- Lymphadénéctomie pelvienne et lombo-aortique
- Cytologie péritonéale et Omentectomie infra gastrique.
- Radiothérapie post opératoire et Curiethérapie post opératoire en cas d'atteinte isolée de la séreuse
- +/- Curiethérapie postopératoire (si atteinte cervicale)
- +/- Chimiothérapie adjuvants (si atteinte annexielle)

Stade IV (tout type histologique) :

- Stade IVA :
- Radiothérapie exclusive : radiothérapie externe (45 Gy) suivie de curiethérapie.
- +/- Chimiothérapie concomitante (par analogie au cancer du col de l'utérus) (peut être discutée)
- +/- Chimiothérapie adjuvante séquentielle (si échec de l'irradiation)
- Stade IVB :
- Une chirurgie de cytoréduction complète à visée curative identique à celle réalisée du cancer de l'ovaire est recommandée uniquement si carcinome péritonéale résectable sans métastase à distance
- +/- Si stade IVB défini par l'atteinte inguinale isolée : Adénéctomie complémentaire
- Radiothérapie externe sur la tumeur primitive.
- Chimiothérapie +/- Hormonothérapie (si récepteurs hormonaux positifs)

Stade IIC :

- Lymphadénéctomie lombo-aortique immédiate ou différée (si lymphadénéctomie pelvienne +/-)
- Radiothérapie externe post-op après stadification histologique complète (pelvienne et L4-5)
- Pelvienne au stade IIC, pelvienne et L4-5 IICa) suivie d'une curiethérapie.
- +/- Chimiothérapie adjuvante séquentielle (si atteinte annexielle)
- Stade IICa : (pour le IICa, 2 options : radiothérapie ou chirurgie selon conditions)
- IICa ou IICa avec conditions favorables pour une chirurgie
- Hystérectomie totale et annexectomie bilatérale, Lymphadénéctomie pelvienne et lombo-aortique
- Radiothérapie externe pelv (L4-5 si IICa) suivie de curiethérapie vaginale post-opératoire
- IICb :
- Radiothérapie externe Pelv et L4-5 suivie d'une surimpression GG et de curiethérapie
- +/- Chimiothérapie adjuvante séquentielle (IICa : peut être discutée ; IICb : doit être discutée)

XI. SURVEILLANCE :

- Examen clinique général (palpation des aires gg) et gynécologique (+ frottis) :
 - Tous les 6 mois pendant 3 ans.
 - Tous les ans après 3 ans.
- Toute patiente symptomatique doit être explorée.
- Examens complémentaires à la recherche de récurrences et/ou de métas si signes d'appel.
- THS discuté en l'absence de facteurs de mauvais pronostic.

XII. CONCLUSION :

- Cancer de l'endomètre : 1^{er} diagnostic à évoquer devant des métrorragies post ménopausiques.
- Diagnostic : histologique.
- Facteurs pronostiques +++.
- Traitement essentiellement chirurgical.
- Surveillance post opératoire : clinique + frottis du dôme vaginal (car risque important de récurrences sur la tranche vaginale).

*Compléments TTTT :

Groupe à faible risque	*Endométrioïde, IA, G1-G2, EV (embolie Vx) :-	*Taux de rechute : 0-3% → Surveillance simple
Groupe à risque intermédiaire haut:	*Endométrioïde, IA, G3, EV: +ou- *Endométrioïde, IA-IB, G1-G2, EV: +	*Curiethérapie vaginale: +++ *RTE: EV+, statut N ? *Surveillance simple: ---
Groupe à haut risque :	*Endométrioïde, IB, G3, EV: +ou- *Endométrioïde, stade II et III R- *Non endométrioïde stade I à III → Risque important de récurrence locale et d'évolution M+	*RTE +/- chimio : essais en cours *Curiethérapie vaginale

Cas particulière : SD de Lynch

- Chez toutes les patientes présentant un cancer de l'endomètre avant 50 ans
- Quel que soit l'âge chez une patiente dont un apparenté au premier degré a été atteint d'un cancer colorectal ou du « spectre HNPCC » (endomètre, intestin grêle, urothélium, voies biliaires, estomac, ovaire).

Modalités : Examen clinique + échographie gynécologique + biopsie de l'endomètre +/- HST.

- HST+AB peut être proposé à partir de 40 ans.

Cas particulier : Sd de Lynch